Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Naviraí
1.ª Vara Cível

SENTENÇA

Vistos e examinados estes autos sob nº 0802983-02.2024.8.12.0029 de **AÇÃO Procedimento Comum Cível** em que é **Autor:** Olivia Madalena Pereira e **Réu:** Cassems - Caixa de assistência dos Servidores do Estado de MS e outros

Olivia Madalena Pereira, qualificada nos autos, move a presente *Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada de Urgência* em desfavor do **Município de Naviraí** e do **Estado de Mato Grosso do Sul,** também qualificados, dizendo, em resumo, que é pessoa idosa e foi acometida de Fibrose Pulmonar Progressiva, necessitando fazer uso do remédio *OFEV (nintedanibe)150mg* para tratamento de seu problema de saúde. Afirma que não conseguiu obter o medicamento na rede pública de saúde e que ele é indispensável ao seu tratamento, não lhe restando outra saída senão o ajuizamento da presente ação. Com base em tais fatos sucintos, objetiva a condenação dos Requeridos para que lhe forneça o medicamento o medicamento *OFEV (nintedanibe)150mg*, para uso continuo de 1cp de 12/12 horas. Apresentou outros requerimentos. Instruiu a inicial com os documentos de fls. 17/124.

Parecer do Núcleo de Apoio Técnico às fls. 125/135.

Determinada a intimação da Autora para que informe, corretamente, o polo passivo a ação, se contra o Poder Público (Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Naviraí) ou contra a operadora de plano de saúde (CASSEMS) (fls. 136/137).

Emenda à inicial apresentada, às fls. 138, pleiteando a exclusão da CASSEMS da demanda.

Tutela de urgência deferida (fls. 139/144).

Citados os Requeridos ofereceram contestação às fls. 155/161 e 167/177.

O Requerido Estado de Mato Grosso do Sul na contestação ofertada, em síntese, discorreu pela necessidade de preencgimento dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 1.234 e Tema 6 para o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS. Pugnou pela improcedência do pedido.

Às fls. 162, o Estado apresentou acordo administrativo firmado com o Município para fins de cumprimento da tutela de urgência.

O Requerido Município de Naviraí em sua defesa alegou, em suma, que não possui recurso financeiros para o fornecimento do medicamento pleiteado. Que o Esilato de Nintedanibe não está padronizado e a paciente está sendo atendida por médico particular. Pleiteou pela aplicação da tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VIRCO ANTONIO, liberado nos autos em 17/06/2025 às 16:18 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802983-02.2024.8.12.0029 e código QzH2k0CB.

1.657.156/RJ (TEMA 106). Ao final, requereu a improcedência da presente ação (fls. 167/177).

Às fls. 196/203, o Município requereu que os autos sejam remetidos à Justiça Federal.

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (CASSEMS) apresentou contestação, arguindo sua ilegitimidade passiva. Requereu sua exclusão da lide (fls. 210/227).

A parte autora apresentou impugnação à contestação (fls. 292/297).

Na fase de especificação de provas, as partes disseram não possuir provas para produção (fls. 306, 309/313 e 321).

Às fls. 326/338 foi juntado ofício referente ao Agravo de Instrumento n. 2001252-57.2024.8.12.0000.

É o relatório no essencial.

Decido.

Inclusão da União e Competência da Justiça Federal

O Município de Naviraí pede a remessa do presente feito à Justiça Federal, afirmando que, por se tratar de medicamento não padronizado, a competência para julgamento seria da União.

A questão foi objeto do Tema 1.234, no qual o Supremo Tribunal Federal, dentre outras definições, estabeleceu:

> *I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, **as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal**, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, **quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo**, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), **for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos**, na forma do art. 292 do CPC.*

Desse modo, a Justiça Federal será competente para conhecer e julgar as demandas que objetivam o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, cujo Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG) seja igual ou superior a 210 salários-mínimos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VIRCO ANTONIO, liberado nos autos em 17/06/2025 às 16:18 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802983-02.2024.8.12.0029 e código QzH2k0CB.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Naviraí
1.ª Vara Cível

No caso, a autora pleiteia o fornecimento do medicamento *OFEV (nintedanibe)150mg*, prescrito na quantidade de 1 comprimido a cada 12 horas, ou seja, 60 comprimidos por mês. Em relação ao valor do tratamento anual específico do fármaco/princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG), o NAT informou às fls. 134:

> **X - Em caso de pedido de medicamento genérico, observar se a prescrição se utilizou da legislação vigente e se existe possibilidade de substituição;**
> O Esilato de Nintedanibe tem genérico e similar. Preços conforme tabela CMED/ANVISA (PF: preço de fábrica, PMC: preço máximo ao consumidor; PMVG: preço máximo de venda ao governo).
> - OFEV (BOEHRINGER INGELHEIM) 150 MG CÁPSULA X 60. PF: R$ 22.150,98, PMC: R$ 29.5295,59, PMVG: R$ 17.381.87.
> - NIDHI (SUN DO BRASIL) 150 MG CÁPSULA X 60. PF: R$ 22.150,96, PMC: R$ 29.525,56, PMVG: R$ 17.381,86.
> - ESILATO DE NINTEDANIBE (SUN DO BRASIL) 150 MG CÁPSULA X 60. PF: R$ 14.398,12, PMC: R$ 19.191,61, PMVG: R$ 11.298,20.

Assim, levando em consideração o PMVG de R$17.381,87 para o fármaco pleiteado, tem-se que o valor do tratamento anual prescrito seria R$208.582,44, montante que não ultrapassa o valor de 210 salários-mínimos, ou seja R$318.780,00, considerando o salário-mínio atual (R$1.518,00).

Portanto, a competência para o processamento e julgamento da presente demanda é desta Justiça Estadual, sem inclusão/remessa à União.

<u>Do mérito</u>

Conheço diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do Novo Código de Processo Civil, pois desnecessária a produção de outras provas, o que, aliás, não foi requerido por nenhuma das partes.

O ordenamento jurídico brasileiro tutela o direito à saúde, determinando o artigo 196 da Constituição Federal que:

> Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Por sua vez, a Lei n.º 8.080, de 19/9/90, que trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, estatui em seu artigo 2.º que *"A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício"*. E, no artigo 7.º, que:

> "As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde − SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:
> I − universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VIRCO ANTONIO, liberado nos autos em 17/06/2025 às 16:18 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802983-02.2024.8.12.0029 e código QzH2k0CB.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Naviraí
1.ª Vara Cível

> II − integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;
> IX − descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo: a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;".

Basta o dispositivo previsto no texto constitucional citado para se chegar à conclusão de que se deve garantir o direito de todos, independentemente da condição financeira, à saúde.

As normas infraconstitucionais, que procuram dar efeito integrador ao texto constitucional, seriam até desnecessárias se existisse a consciência, por parte de todos os responsáveis pelas administrações dos entes federados, de que a Constituição Federal não é puramente analítica. A Constituição, com sua força normativa, constitui energia que deve influir na realidade.

O dever da Administração de adquirir o necessário ao atendimento de pessoas doentes, imposto pela Constituição, não pode ser inviabilizado por entraves burocráticos e questiúnculas referentes à competência deste ou daquele órgão para distribuição. A distribuição de competências entre os entes federados é firmada para melhor servir aos cidadãos e não para aumentar seus sofrimentos e angústias, motivo pelo qual há solidariedade entre eles.

Assim, como a Carta Magna traz a promessa de ampla proteção no campo da saúde, não pode o ente público se esquivar da sua obrigação, até porque estamos diante de tema que perpassa pela dignidade da pessoa humana. O Tribunal de Justiça do Estado, a respeito do tema já decidiu:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 12.401/2011 – PREVISÃO CONSTITUCIONAL QUE PREVALECE SOBRE LEI, PORTARIA OU ATO NORMATIVO INFERIOR – DIREITO À SAÚDE – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR – PERIGO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – MEDICAMENTO EXPERIMENTAL – SEM RELEVÂNCIA DESDE QUE INDICADO POR MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE – RECURSO IMPROVIDO. Não há que se falar no reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei n. 12.401/2011, posto que já é pacífico o entendimento de que a garantia ao acesso igualitário das pessoas saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal está acima de qualquer lei, portaria ou ato normativo inferior. Uma vez sopesados os interesses de ambas as partes, verifica-se que o princípio da integralidade que é fundamento do interesse do recorrente, não deve prevalecer sobre o princípio basilar da pretensão do recorrido, que é o da dignidade da pessoa humana. Diante da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, como a prova inequívoca do direito e a verossimilhança das alegações acerca da necessidade do medicamento pleiteado, a decisão a quo deve ser mantida. Já é sedimentado o entendimento de que, se beneficiar o paciente, o médico pode utilizar um medicamento para finalidades diversas das indicadas, mesmo que em fase experimental. (TJMS, Quarta Câmara Cível, relator Desembargador Claudionor Miguel Abss Duarte, agravo nº 2012.015841-8, julgado em 17.07.2012).*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VIRCO ANTONIO, liberado nos autos em 17/06/2025 às 16:18 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802983-02.2024.8.12.0029 e código QzH2k0CB.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Naviraí
1.ª Vara Cível

Desse modo, é patente a responsabilidade dos réus quanto ao atendimento das demandas relacionadas à saúde, o que, de resto, ficou assentado pelo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 793, que estabeleceu a seguinte tese:

> Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, **compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento** conforme as regras de repartição de competências **e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro**. (Grifei)

Demonstrada a responsabilidade dos requeridos, verifico que, no caso, a parte autora demonstrou que possui uma demanda na área da saúde e que não conseguiu deles, administrativamente, o medicamento de que necessita.

Importa destacar, outrossim, que para o medicamento *OFEV (nintedanibe)150mg*, que não está padronizados pelo SUS (fls. 132, item VII), devem ser atendidas as exigências estabelecidas nos temas 106/STJ e 1.234/STF para que seja viável compelir os entes demandados a fornecê-lo.

Pois bem, primeiramente, cabe salientar que o preenchimento dos requisitos exigidos pelo Resp 1.657.156 (Tema 106), já foram analisados por este Juízo por ocasião da decisão que deferiu a tutela provisória (fls. 139/144), cujos fundamentos mantiveram inalterados durante o transcorrer processual, de modo que os reitero *in tontum:*

> "De acordo com tal recurso especial para o fornecimento de remédios fora da lista do SUS, deve restar preenchidos os seguintes requisitos:
>
> ***(i)*** *Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;*
> ***(ii)*** *incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;*
> ***(iii)*** *existência de registro na ANVISA do medicamento.*
> [...]
> Os dois últimos requisitos exigidos pelo REsp em comento são de fácil constatação, pois denota-se que o remédio pretendido possui registro na ANVISA (fls. 132, item IV) e que a Requerente trata-se de pessoa hipossuficiente, já que se encontra assistido pelo Núcleo de Prática e Assistência Jurídica da Unidade Universitária da UEMS de Naviraí, e declara tal condição às fls. 17.
>
> Com relação ao primeiro requisito, [...], está devidamente demonstrado nos autos por meio do laudo médico de fls. 22/93, o qual afirma a imprescindibilidade do medicamento prescrito, não podendo ele ser substituído. Veja:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VIRCO ANTONIO, liberado nos autos em 17/06/2025 às 16:18 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802983-02.2024.8.12.0029 e código QzH2k0CB.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Naviraí
1.ª Vara Cível

Essa patologia não possui cura, tem caráter progressivo, porém, há alguns anos foi observado melhora e estabilização das lesões pulmonares com o uso de novos antifibróticos, onde observou-se controle dos sintomas e da progressão com o uso da medicação Nintendanibe 150mg uso contínuo e ininterrupto não havendo fórmulas para manipulação. Sendo, portanto, tal medicação orientada pela SBPT (sociedade brasileira de pneumologia e tisiologia), consensos norte americanos e europeu para tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI) e Fibrose Pulmonar Progressica (FPP) com melhor sobrevida e estabilização da função pulmonar.

Ha necessidade URGENTE da disponibilização dessa medicação tendo em vista o caráter progressivo da doença e limitação significativa pelos sintomas da paciente e piora da qualidade de vida, com risco de exacerbações e idas frequentes em unidades de emergência.

fls. 22

Portanto, resta apenas esta opção para ao paciente supracitado, haja vista que para aumentar sua sobrevida e diminuir internações necessita de um antifibrótico.

Enfatizo novamente que o SUS não disponibiliza nenhum tratamento para fibrose pulmonar – prednisona e azatioprina não são mais usados para tratamento da doença.

fls. 25

Ainda, a médica que elaborou o laudo supracitado afirmou que não há nenhum outro medicamento semelhante disponível no SUS, além de que já foram utilizadas outros medicamentos, porém constatada a ineficácia.

6. Descrever se existe medicamento genérico ou similar que possa substituir aquele ora prescrito:
( ) sim (x) não ( ) prejudicado
Se sim indicar qual :_____.

7. Esclarecer se a alternativa terapêutica do SUS para a moléstia a seguir indicada já foi utilizada:
(X) antitussígeno ( ) morfina (x) corticoterapia ( ) oxigenioterapia ( ) transplante de pulmão

7.1 Por quanto tempo foi utilizada:
( ) + de 1 ano ( ) + de 06 meses (X) – de 6 meses ( ) prejudicado

7.2 O paciente permanece em uso de tal medicamento/tratamento:
(x) sim- especifique qual: ANTITUSSIGENO ( ) não

7.3 Em relação à(s) alternativa(s) disponível(is) pelo SUS já utilizada(s) explicar eventual ineficácia e/ou contraindicação ao(à) paciente com base nos resultados clínicos produzidos:
ANTITUSSÍGENOS TEM EFEITO PARCIAL SOBRE A TOSSE, SENDO INEFICAZ PARA FALTA DE AR. MORFINA E OXIGENIOTERAPIA NÃO FORNECEM ALÍVIO DA FALTA DE AR, PORÉM NÃO ALTERAM A SOBREVIDA DO PACIENTE EM LONGO PRAZO.

7.4. Quanto à(s) alternativa(s) do SUS anteriormente elencada(s) que porventura não tenha(m) sido utilizada(s), esclareça tecnicamente porque não foi(ram) prescrita(s) ao(à) paciente:
( ) contraindicação ( )efeitos adversos (X)ineficácia ( )resposta terapêutica insatisfatória
( ) outro motivo: Qual: _____
Justificar: SEGUNDO AS DIRETRIZES BRASILEIRAS PARA O TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DA FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA 2020, A PIFERIDONA É UM MEDICAMENTO RECOMENDÁVEL, PORÉM NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SUS. CORTICOTERAPIA, MACITENTANA, BOSENTANA, SILDENAFINA, TERAPIA COM ANTIÁCIDO E N-ACETILCISTEÍNA NÃO SÃO RECOMENDADOS POR ESSE MESMA DIRETRIZ.

8.Existe(m) no SUS medicamento(s) que possua(m) a mesma eficácia terapêutica daquele(s) ora prescrito(s)?
( ) Sim (X) Não

fls. 40

Portanto, ante as informações descritas no documento de fls. 22/93, tem-se está preenchido o requisito sob análise.

No mais, o Núcleo de Apoio técnico emitiu parecer favorável ao fornecimento do medicamento pleiteado (fls. 125/135) [...]"

Outrossim, a respeito das exigências para o fornecimento de medicamentos não incorporados às políticas públicas trazidas pelo Tema 1.234, o STF firmou

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VIRCO ANTONIO, liberado nos autos em 17/06/2025 às 16:18 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802983-02.2024.8.12.0029 e código QzH2k0CB.

as seguintes teses:

> *IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS*
> *4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC),* ***o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.*** *4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3)* ***Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.*** *4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR,* ***não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.*** – destaquei

Desse modo, tornou-se imprescindível o exame judicial do ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa. Ainda, é do autor o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto incorporado pelo SUS.

Quanto à negativa de fornecimento na via administrativa, verifico que a autora buscou administrativamente o fármaco *OFEV (nintedanibe)150mg* junto aos entes públicos, todavia, foi informada pelo Município de Naviraí que ele *não se encontra nas listas de medicamentos CAFE e RENAME, ou seja, não é fornecidos através do SUS* (fls. 97).

Em relação ao exame dos atos normativos da Conitec, como informado pelo NAT às fls. 132 (item VII): "a CONITEC avaliou o *Nintedanibe* no Relatório de recomendação nº 419 Esilato de nintedanibe para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática (CONITEC, dezembro/2018)", opinando pela não incorporação desse medicamento.

Todavia, verifica-se uma omissão relevante na avaliação da incorporação do fármaco, dado que os estudos utilizados pela Conitec datam de 2018, sem que haja atualização baseada em novas evidências científicas apresentadas nos autos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VIRCO ANTONIO, liberado nos autos em 17/06/2025 às 16:18 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802983-02.2024.8.12.0029 e código QzH2k0CB.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Naviraí

1.ª Vara Cível

Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte Estadual também tem se orientado no sentido da viabilidade do fornecimento do *OFEV (nintedanibe)150mg* em hipóteses similares:

> DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. DIREITO À SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão judicial de medicamento não padronizado pelo SUS é admissível desde que comprovadas a imprescindibilidade do tratamento, a ineficácia das opções fornecidas pelo SUS e a incapacidade financeira do paciente, conforme diretrizes dos Temas 6 e 1234 do STF. 4. A parte agravante apresenta prescrição médica circunstanciada e atualizada, atestando a essencialidade do medicamento Nintedanibe para o controle da Fibrose Pulmonar Idiopática, enfermidade grave com risco iminente de morte e progressão acelerada. 5. O parecer técnico do NAT-JUS confirma a ausência de alternativas terapêuticas eficazes disponíveis no SUS, indicando como única opção o transplante pulmonar, inviável no caso em razão da idade da paciente. 6. **A defasagem das avaliações da CONITEC, datadas de 2018, frente às evidências científicas atuais, corrobora a excepcionalidade do caso e a necessidade de revisão da negativa administrativa.** 7. A jurisprudência da Corte Estadual reconhece a possibilidade de concessão de medicamentos fora da lista oficial, em situações de urgência e comprovada necessidade clínica, como nos precedentes citados. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1) É admissível a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS quando comprovada, por laudo médico fundamentado, a imprescindibilidade do fármaco, a ineficácia das alternativas terapêuticas oferecidas pelo sistema público e a hipossuficiência do paciente. 2) **A ausência de atualização das avaliações da CONITEC diante de novas evidências científicas pode caracterizar omissão relevante a justificar a concessão judicial do tratamento.** 3) A tutela de urgência deve ser deferida quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, especialmente em casos envolvendo risco à vida ou à saúde. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 6 e 1234 da repercussão geral; TJMS, AI n. 1420713-64.2024.8.12.0000; AI n. 1420980-36.2024.8.12.0000; AI n. 2000097-82.2025.8.12.0000. (**TJMS**. Agravo de Instrumento n. 1406845-82.2025.8.12.0000, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, j: 05/06/2025, p: 06/06/2025) – grifei

Por fim, quanto à comprovação, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, da segurança e eficácia dos fármacos, bem como da inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, entendo que os elementos constantes nos autos são suficientes para comprovar a imprescindibilidade do tratamento.

Além do relatório médico (fls. 22/25) e questionário (fls. 39/41), nos quais a médica pneumologista que acompanha a paciente atestou a imprescindibilidade do medicamento, alegando que ele não pode ele ser substituído, ainda, o Parecer do NAT trouxe informações e evidências científicas satisfatórias sobre o *Ofev*, em especial para doenças pulmonares, que é o caso da autora (fls. 130/132, item III).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VIRCO ANTONIO, liberado nos autos em 17/06/2025 às 16:18 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802983-02.2024.8.12.0029 e código QzH2k0CB.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Naviraí
1.ª Vara Cível

Portanto, restou comprovada, consoante exigências estabelecidas nos temas citados, a necessidade de realização de tratamento com este medicamento em específico, de maneira que a procedência do pedido é a medida que se impõe.

Do dispositivo

Ante o exposto, confirmando neste momento a antecipação dos efeitos da tutela, **JULGO PROCEDENTE** o pedido que **Olivia Madalena Pereira** fez em desfavor do **Município de Naviraí** e do **Estado de Mato Grosso do Sul**, qualificados, para o fim de determinar aos réus que forneçam por meio de seus órgãos executores competentes, à parte autora o medicamento ***OFEV (nintedanibe) 150mg***, pelo nome comercial ou princípio ativo, na quantidade necessária para seu tratamento e mediante a apresentação de receituário médico, no prazo de 20(vinte) dias, a contar da intimação dos Réus do teor desta decisão.

Deixo de fixar multa pelo descumprimento da obrigação, pois, segundo consta dos autos em apenso, o medicamento vem sendo fornecido (vide fls. 67 dos autos n. 0800594-10.2025.8.12.0029).

Uma vez que o NAT não foi expresso a respeito das normas que definem a competência do Município e do Estado de Mato Grosso para o fornecimento da medicação acima, deixo de dar aplicação tema 793 do STF para manter a responsabilidade solidária entre os entes públicos demandados.

Sem custas, *ex vi legis*.

Condeno os Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$800,00 (oitocentos reais), com fulcro no art. 85, §8º do CPC, já considerado o grau de zelo do profissional, a importância e a natureza da causa, o tempo e o lugar da prestação do serviço. Ainda, com fulcro no art. 87, § 1º, do CPC, determino a distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais em 50% entre os litisconsortes passivos.

Considerando a determinação de fls. 136/137, atendida pela autora às fls. 138, **EXCLUA, imediatamente**, do polo passivo da presente demanda junto ao SAJ o Requerido **Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (CASSEMS).**

Declaro **extinto** o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Sentença sujeita a reexame, pois não é certo o valor da condenação, nos termos do art. 496, §3º, do CPC e Súmula 490 do STJ. Assim, decorrido o prazo recursal, mesmo sem oposição de recurso pelas partes, remetam-se os autos ao E. TJMS para reexame.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VIRCO ANTONIO, liberado nos autos em 17/06/2025 às 16:18 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802983-02.2024.8.12.0029 e código QzH2k0CB.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Naviraí
1.ª Vara Cível

Havendo o trânsito em julgado, arquive-se com as formalidades.

P.R.I.C.

Naviraí/MS, datado e assinado digitalmente.

Eduardo Magrinelli Júnior
Juiz de Direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VIRCO ANTONIO, liberado nos autos em 17/06/2025 às 16:18 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802983-02.2024.8.12.0029 e código QzH2k0CB.